PLANO DE CONTINGÊNCIA DE

COMBATE AS ARBOVIROSES

CÓRREGO DO OURO - GO

2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CÓRREGO DO OURO

SECRETÁRIA: Viviane Elize Campos
COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE: Johnatha Kennedy Faleiro Ribeiro
DEPARTAMENTO ENDEMIAS: Maurivânio Gonçalves Martins – Carlos Alberto de Souza - Divina Aparecida Ramos David Souza.

ELABORAÇÃO: NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Apresentado no Conselho Municipal de Saúde em: 12/3/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO OURO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1. INTRODUÇÃO

O Plano de Contingência é um documento elaborado com o intuito de auxiliar a Prefeitura na resposta a uma epidemia arboviroses, condição que pode determinar sérios danos às pessoas, ao meio ambiente e à economia da cidade.

Dessa forma, apresentamos neste documento o planejamento de ações a serem adotadas pelas diversas áreas técnicas da Secretaria municipal de Saúde no intuito de conter a transmissão de arboviroses no município de Córrego do Ouro, e assim diminuir a probabilidade de ocorrência de casos graves e consequentemente dos óbitos.

Participam deste plano todos os Departamentos da Secretaria Municipal de saúde de Córrego do Ouro de forma integrada.

Em 2020 os casos de arboviroses, tiveram suas notificações afetadas devido a pandemia do Covid 19, com tudo os trabalhos não foram suspensos, porem a preocupação instalada prejudicou os trabalhos a serem realizados.

Os trabalhos entre as equipes que prestaram assistência aos doentes nas unidades de saúde e equipe de controle de vetores foi sincronizado com as ações de combate ao *Aedes aegypti e Aedes Albopictus*, não havendo plano de contingência, optou-se pela elaboração como forma de direcionar e otimizar os trabalhos das equipes.

O Plano de contingência aqui apresentado continuará na linha de trabalhos com uma política de intersetorialidade de forma a manter as demais secretarias de município como: Limpeza Urbana, Obras e DMER, Educação, Meio ambiente e com a sociedade civil, pensando no controle do *Aedes Aegypti e Aedes Albopictus* como uma ação de responsabilidade social e coletiva, não se restringindo apenas as equipes de saúde.

As ações que serão desenvolvidas pelo plano municipal de contingência no controle das arboviroses: constarão nos tópicos abaixo deste documento.

1.1. Características do Município

O município de Córrego do Ouro está situado no Oeste Goiano, a cerca de 167 km da capital do Estado de Goiás - Goiânia. Possui uma topografia irregular, com paisagens cercadas por serras e a vegetação predominante é o Cerrado. A população estimada 2.254 habitantes (IBGE 2021), com área territorial de 458.077 km².

O município possui aproximadamente 1.737 imóveis, distribuídos pela sede do município e 05 (cinco) distritos ou pequenos povoados (Espirito Santo, Cedro, Queixada, Aldeia dos Pilões 1 e 2, Carmolândia que recebem periodicamente as visitas dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate as endemias na contenção de arboviroses, que são atendidos por 01 unidade de programa saúde da família, um Hospital Municipal de pequeno porte, um laboratório de análises clínicas, pelo Núcleo de Vigilância Epidemiológica com participação da Vigilância Sanitária.

2. OBJETIVOS

3. 2.1. GERAL

- Evitar a mortalidade por arboviroses;
- Reduzir os índices dos casos de arboviroses;
- Promover ações de combate ao mosquito *Aedes aegypti e Aedes Albopictus* através de medidas de controle ambiental (mecânico e químico) que vise reduzir criadouros evitando a proliferação da doença;
- Prover discussões e conscientizar os profissionais da rede de saúde do município com enfoque na qualidade da assistência;
- Desenvolver ações que promova a interdisciplinaridade e Inter setorização entre outras secretarias para disseminar informações, aos diversos setores da população, no sentido de minimizar o impacto social e econômico;
- Qualificar a vigilância com notificações e investigação oportuna dos casos, utilizando as informações como base para tomadas de decisões;
- Qualificação da rede assistencial no manejo clinico das formas graves das doenças, de modo a reduzir a ocorrência de óbitos.

2.2. ESPECÍFICOS

- Subsidiar as equipes de saúde de Controle de Endemias, com insumos estratégicos, EPIs e veículos para desenvolvimento das ações evitando a transmissão das arboviroses;
- Garantir que as equipes de assistência realizem o diagnóstico precoce, manejo clínico adequado, preenchimento da ficha de notificação compulsória dos casos suspeitos de arboviroses;
- Manter o fluxo de amostras para diagnóstico laboratorial pelos serviços de saúde pública, realizando coleta de material para exame em pelo menos 80% dos suspeitos de dengue, 100 % dos casos suspeitos de Chikungunya, Zika e outras arboviroses;
- Definir estratégicas de controle ambiental para equipes de Controle de Endemias e Agentes Comunitários de saúde para diminuir as pendências de imóveis fechados e ou com recusa;
- Manter ações contínuas de capacitação e integração dos ACS (Agentes comunitários de saúde) e ACE (Agentes de Controle de Endemias);

2.3. Diagnóstico situacional:

2.3.1. Quadro: Número casos de confirmados por Dengue de residentes em Córrego do Ouro. Período dos anos de 2022 a 2024.

ANO	2022	2023	2024
Nº CASOS	156	03	51

2.3.2. Quadro: Número casos de confirmados por Chikungunya de residentes em Córrego do Ouro. Período dos anos de 2022 a 2024.

ANO	2022	2023	2024
Nº CASOS	01	00	00

Fonte: http:// Sinan.saude.gov.br/sinan

2.3.2. Não houveram casos notificados de suspeita de outras arboviroses no período.

3. AÇÕES

3.1. AÇÕES DE GESTÃO MUNICIPAL

- Aquisição e estoque de materiais e insumos estratégicos para controle a endemias e assistência a pessoas suspeitas de arboviroses;
- Manter e contratar recursos humanos para reposição do quadro de servidores da secretaria de saúde, principalmente agentes de endemias e agentes comunitários de saúde para manutenção do trabalho de prevenção e promoção em saúde;
- Repor os veículos sem condições de uso para transporte das equipes de controle a endemias por veículos novos, assim como estabelecer uma agenda com o setor de frotas da secretaria de saúde de 01 veículo para as unidades de estratégia saúde família garantindo as visitas domiciliares nas investigações de casos suspeitos e confirmado para seu efetivo acompanhamento;
- Adequação do espaço ocupado pelo setor de Vigilância Epidemiológica.

3.2. AÇÕES DE CONTROLE ENDEMIAS:

- Alimentar e consolidar o sistema de informação (SIMAZ) com os dados dos boletins entomológicos das ações realizadas casa-casa pelas equipes de agentes de endemias e agentes comunitários de saúde;
- Manter contato com a equipe de endemias de cidades circunvizinhas e regional de Saúde Oeste II para análise do cenário regional;
- Promover e organizar os manejos ambientes para mutirões de combate ao mosquito, cabendo a endemias a organização e direcionamento dos trabalhos;

- Monitorar através sistema (SIMAZ) o nível de infestação dos criadores predominantes do vetor, na comunidade, nos pontos estratégicos e imóveis especiais e disparar ações rápidas de controle o que permitirá a detecção de alterações no padrão de comportamento da doença e nos momentos de implantação das diferentes fases do plano de contingência;
- Realizar ADL (avaliação de densidade larvária) e LIRA (levantamento rápido de infesta conforme diretrizes do Ministério da Saúde;
- Manter os agentes de Controle de Endemias nas Unidades de Saúde da Família, para realização de demandas imediatas, estreitar vínculo com as equipes de saúde ESF e população através de trabalhos de IEC (informação, educação e comunicação);
- Realizar visitas em imóveis especiais: creches, escolas, comércios para orientações e cuidados de prevenção;
- Realizar nebulização costal e peri focal em áreas com grande infestação de alados com casos confirmados ou suspeitos de arboviroses, pontos estratégicos e imóveis especiais conforme normas técnicas;
- Manter vigilância e avaliação através do programa SIMAZ dos Pontos Estratégicos e Imóveis Especiais, mantendo atualizado o cadastro para reclassificação quanto ao risco e cancelamento do mesmo para aqueles que melhoraram as condições sanitárias; realizando suas visitas de acordo com as normativas técnicas recomendadas;
- Priorizar fiscalizações em Pontos estratégicos e imóveis com grande acúmulo de lixo em parceria com a equipe de vigilância sanitária, assim como atender as denúncias feitas pela população;
- Realizar o bloqueio de casos suspeitos e confirmados arboviroses oportunamente conforme recomendação técnica;
- Manter atualizado o cadastro dos PE's para reclassificação quanto ao risco e cancelamento do cadastro daqueles que melhoraram as condições sanitárias;
- **Pendências**: Realizar parcerias com a com a Secretaria de Educação, meio ambiente, limpeza e urbanização junto a população utilizando-se de planos alternativos de mobilização social com trabalhos, durante a semana e aos sábados de intensificação e mutirões esporádicos para redução das pendências e imóveis fechados e remoção de possíveis reservatórios de *Aedes aegypti e Aedes Albopictus.*

3.3. EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO e MOBILIZAÇÃO SOCIAL

- Manter canais de comunicação e informação com o público escolar e população em geral por meio de redes sociais, anúncios, panfletos e cartazes;

- Motivar a comunidade a refletir sobre arboviroses e eliminar criadouros;
- Divulgar informações periódicas de dados epidemiológicos e entomológicos;
- Capacitar e sensibilizar os profissionais de saúde através educação permanente, para o plano de ação rápida nas diferentes áreas de risco quando detectar aumento do número de arboviroses;
- Estimular população para participação de fórum, debates e comitês das arboviroses;

3.4. AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA

- Receber e investigar todos os casos suspeitos de arboviroses recebidos das unidades de saúde do município, assim como casos confirmados de Dengue grave e óbitos suspeitos, registrar no Sistema Informação do SINAN online;
- Encaminhar as notificações dos casos suspeitos recebidos do Hospital Municipal e outros serviços de saúde para as unidades de saúde da família, para ciência, acompanhamento e retorno em tempo oportuno para a VE municipal do caso para que ocorra a alimentação do dado no sistema de informação do SINAN online (Ministério da Saúde);
- Auxiliar a equipe de assistência das unidades de saúde com objetivo de garantir o manejo adequado ao paciente (provocando discussões e elaborando treinamentos), prover capacitação permanente para profissionais médicos, enfermeiros e demais técnicos em saúde em manejo clínico, diagnóstico precoce e tratamento adequado das arboviroses;
- Orientar as unidades de saúde sobre a coleta, armazenamento e envio das amostras de exames para laboratório para diagnóstico sorológico, testes rápidos/NS1 para arboviroses e controle de exames de hematócritos e plaquetas;
- Acompanhar junto do laboratório municipal o andamento dos exames de sorologia enviados para o LACEN (Laboratório Central do Estado), após resultados encaminhá-los para as unidades de saúde de sua referência, bem como manter atenta ao sistema de resultados online do (GAL) dos resultados pendentes;
- Acompanhar semanalmente a evolução dos indicadores epidemiológicos do SINAN ONLINE, monitorar a ocorrência de casos de óbitos e da circulação viral;
- Manter fluxo de notificação rápida dos endereços dos casos suspeitos de arboviroses para equipes de controle de endemias para realização dos bloqueios/ intervenções necessárias;
- Promover o permanente acompanhamento da execução das ações realizadas, avaliar os resultados obtidos, redirecionar e adequar as estratégias se necessário;
- Articular a convocação das equipes de saúde para a reunião na sala de situação das arboviroses mensalmente, discutir as dificuldades e problemas encontrados na rede de assistência e rever

novas estratégias de trabalho para o enfrentamento, utilizando o diagrama de controle do número de casos por semana epidemiológica;

- Manter interlocução com os órgãos regionais, Grupos Técnicos de Vigilâncias: Epidemiológica (GVE), Vigilância Sanitária (GVS) e Superintendência de Controle de Endemias (SUCEN), para acompanhamento da situação epidemiológica e entomológica das arboviroses no município e na região Oeste II;

3.5. AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA

- Solicitar aos fiscais sanitários que em suas vistorias de rotina para atentar-se dos possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti nos estabelecimentos, assim como providenciar a alimentação da informação no sistema do SINAVISA;
- Aplicar auto de infração com penalidade de multa conforme previsto na legislação municipal para correção das irregularidades em situação de risco;
- Alimentar o SINASA (Sistema de vigilância Sanitária), promover regularização dos pontos estratégicos e imóveis especiais sujeitos a inspeção sanitária;
- Participar de visitas junto aos Agentes de Combate às endemias;

3.6. AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA e REDE ESPECIALIZADA

- Assegurar as ações de vigilância epidemiológica das arboviroses em todas as unidades de assistência básica e especializada;
- Preencher a ficha de investigação epidemiológica de preferência o mais breve possível de todos os casos suspeitos;
- Estabelecer Fluxo de Referência e Contra referência, com a Equipe do EMAAB;
- Priorizar a Atenção Básica como porta de entrada principal dos casos suspeitos de arboviroses utilizando o fluxograma de atendimento de casos suspeitos estabelecido pela secretaria municipal de saúde, exames laboratoriais para todos conforme recomendado ministério da saúde;
- As Unidades de Saúde deverão observar no decorrer do período o número de casos, se estiver aumentando para um padrão pré – epidêmico, para organizar com salas de observação e garantir o acompanhamento dos casos mais graves, gestantes de risco discutir o caso com O médico plantonista para possível encaminhamento via regulação;
- Encaminhar para o Hospital municipal de atendimento 24 horas todos os demais casos que a Atenção Básica julgar necessário conforme protocolo clínico e fluxograma municipal;

- Reorganizar o atendimento programático da unidade básica com diminuição das consultas agendadas e ampliação das vagas diárias caso haja sinais de elevação dos casos suspeitos;
- Ficar atentos a situação vacinal da população e imunizar o maior número de pessoas possível com a vacina contra a febre amarela, obedecendo à recomendação técnica da Secretaria de Estado da Saúde.

3.7. AÇÕES DO LABORATÓRIO

- Garantir a coleta de exames complementares, agilidade nos laudos (Hb, Ht, plaquetas, leucócitos) e a colocar os resultados à disposição das unidades de saúde o mais rápido;
- Comunicar as Unidades de Saúde imediatamente por telefone às alterações nos exames laboratoriais dos pacientes considerada fora dos padrões normais principalmente os hemogramas via telefone se possível;
- Comunicar imediatamente a Vigilância Epidemiológica por telefone da entrada de amostras para sorologias arboviroses para obtenção do número SINAN;
- Garantir o envio ao Laboratório - LACEN das amostras sorologias o mais breve possível com o respectivo número do SINAN, além de cadastrar no sistema do GAL (Gerenciador de Ambiente Laboratorial);

3.8. AÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL

- Apresentar o protocolo de fluxo e de assistência ao paciente com arboviroses para toda a equipe técnica envolvida na assistência, (médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem) no Hospital Municipal;
- Capacitar os profissionais quanto ao diagnóstico e manejo dos casos suspeitos de arboviroses, febre amarela;
- Realizar triagem com classificação de risco em todos os casos suspeitos de arboviroses para alerta aos médicos;
- Alertar as equipes para identificação precoce dos casos graves e com sinais de gravidade a fim de garantir assistência médica adequada e de qualidade para os casos bem como a sua regulação para a Central de Vagas conforme protocolo clínico com atualização contínua;
- Realizar exames laboratoriais de acordo com o protocolo estabelecido, para o monitoramento dos casos de arboviroses, assistidos no hospital.

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS PARA 2025 (CONTROLE DE ENDEMIAS)

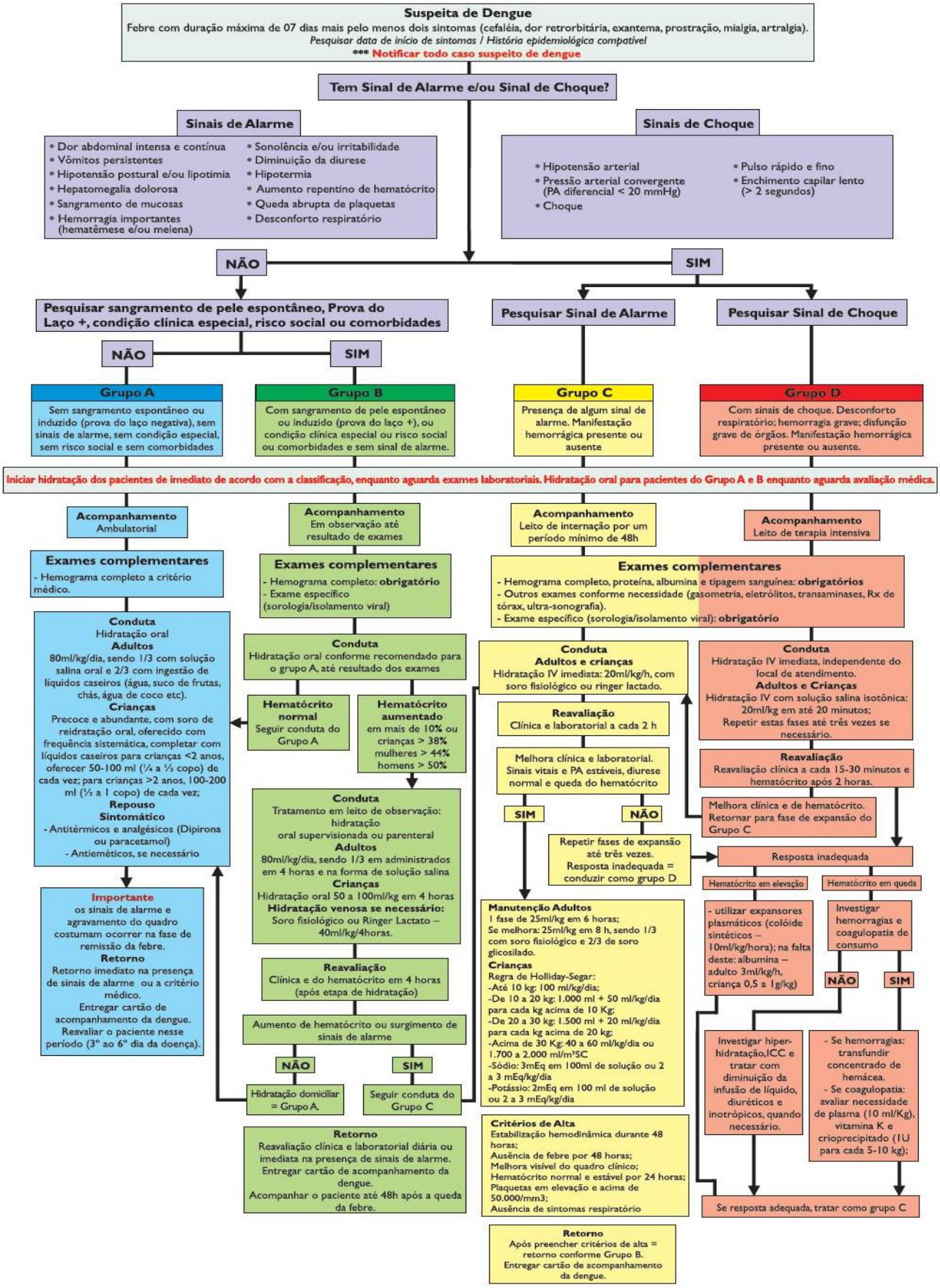
Mês	Ação	Descrição da Ação	Material necessário	Instituições envolvidas	Público alvo	Divulgação
Janeiro	ADL (1ª, 2ª, 3ª, 4ª semanas)	Avaliação Densidade Larvária, dimensionamento dos criadouros existentes, pela contagem dos recipientes com larvas, dando indicação da intensidade da infestação.	Folhetos, pesca larva, pipeta, picola.	Controle de endemias	População e comunidade	Externa
	Intensificar orientações sobre cuidados e eliminação criadouros.	Instalação de Faixas e Totens de alerta e orientação sobre o Aedes Aegypti *e Aedes Albopictus*	Faixas, totens, banner	Endemias	População e comunidade	Externa
	Intensificar orientações sobre cuidados e eliminação criadouros.	Promover intensificação para identificação e eliminação dos criadouros	Anúncio carro de Som, Postagem redes sociais. Faixas, banners	Núcleo de Vigilância Epidemiológica, Endemias.	População e comunidade	Interna / Externa
	Ação educativa nas borracharias e bicicletarias	Estimular e promover nos comércios o descarte adequado dos pneus.	Cartazes / folhetos Termo de notificação Código de Posturas Código Sanitário	Endemias, NVE, Vigilância Sanitária, Posturas, Sec. Meio Ambiente	Borracharias e bicicletarias	Externa
	Ação educativa em construção civil	Visitas a construção, orientação aos trabalhadores	Folhetos	Endemias	Funcionários	Interna
	Vistoria Aérea de prédios e terrenos de difícil acesso	Sobrevoo com drone de PE's, lotes e prédios com impossibilidade de acesso terrestre	Drone	Endemias	PE's, prédios com calhas e telhados com represamento de água.	Externa
	Reforço com equipe	Reforçar com a equipe sobre trabalho no período chuvoso	Sala de reuniões	SMS, AB, NVE, VISA	Colaboradores	Interna
	Coleta Pneus	Coleta de Pneus em borracharias, comércios	Carro com carro com carroceria	Endemias, Meio ambiente	Estabelecimentos que acumulam pneus	Interna
Janeiro a Dezembro	Notificar e acompanhar as notificações e boletins epidemiológicos	Inserir as notificações no SINAN NET, acompanhar e monitorar casos suspeitos, notificados e confirmados	Sistema SINAN NET / Publicações SES/MS	NVE	População e comunidade	Interna
	Divulgar Boletins Epidemiológicos	Divulgar nas redes sociais Boletins Epidemiológicos das Arboviroses	Boletim	NVE	População e comunidade	Interna / Externa
Fevereiro	Manejo ambiental (2ª semana)	Verificação de possíveis criadouros em residências e PEs	Sacos de lixo, tuchos, panfletos. Anúncio Carro de som Redes sociais.	Endemias, ACS, Secretaria Limpeza	População e comunidade	Interna / Externa

				Urbana., Vigilância Sanitária.		
	Ação educativa nas unidades escolares	Palestras contra o Aedes Aegypti	Folhetos	UBS, Seduc municipal, Seduc Estadual, Endemias.	População, estudantes, professores.	Interna / Externa
	Intensificar orientações sobre cuidados e eliminação criadouros.	Promover intensificação para identificação e eliminação dos criadouros	Anúncio carro de Som, Postagem redes sociais. Faixas, banners	Núcleo de Vigilância Epidemiológica, Endemias.	População e comunidade	Interna / Externa
	ADL (1ª, 2ª, 3ª, 4ª semanas)	Avaliação Densidade Larvária, dimensionamento dos criadouros existentes, pela contagem dos recipientes com larvas, dando indicação da intensidade da infestação.	Folhetos, pesca larva, pipeta, picóla.	Controle de endemias	População e comunidade	Externa
Fevereiro a maio	Verificação de Calhas e caixas d'agua.	Verificação de Calhas e caixas d'agua para correção	Uso de escadas e drone	Controle de endemias	População e comunidade	Interna
	Telas em suspiro fossas e reparo de fissuras.	Colocação de telas milimétricas em suspiros de fossas e correção de fissuras	Tela, enforca gato, levantamento das fossas, material para conserto das fossas com fissuras.	Controle de endemias	População e comunidade	Interna
	Intensificar orientações sobre cuidados e eliminação criadouros.	Instalação de Faixas e Totens de alerta e orientação sobre o Aedes Aegypti	Faixas, totens, banner	Endemias	População e comunidade	Externa
	Ação educativa nas borracharias e bicicletarias	Estimular e promover nos comércios o descarte adequado dos pneus, coleta se necessário	Cartazes / folhetos Termo de notificação Código de Posturas Código Sanitário	Endemias, NVE, Vigilância Sanitária, Posturas, Sec. Meio Ambiente	Borracharias e bicicletarias	Externa
	Ação educativa em construção civil	Visitas a construção, orientação aos trabalhadores	Folhetos	Endemias	Funcionários	Interna

	Vistoria Aérea de prédios e terrenos de difícil acesso	Sobrevoo com drone de PE's, lotes e prédios com impossibilidade de acesso terrestre	Drone	Endemias	PE's, prédios com calhas e telhados com represamento de água.	Externa

DENGUE

Classificação de Risco e Manejo do paciente



Condições clínicas especiais e/ou risco social ou comorbidades: lactentes (menores de 2 anos), gestantes, adultos com idade acima de 65 anos, com hipertensão arterial ou outras doenças cardiovasculares graves, diabetes mellitus, DPOC, doenças hematológicas crônicas (principalmente anemia falciforme), doença renal crônica, doença ácidopeptica e doenças auto-imunes. Estes pacientes podem apresentar evolução desfavorável e devem ter acompanhamento diferenciado.

Exames complementares: hemograma obrigatório e outros exames laboratoriais de acordo com a condição clínica associada.

Reclassificar os pacientes após cada avaliação clínica e resultado de exames seguindo protocolo da dengue e vigilância clínica específica (condições associadas).

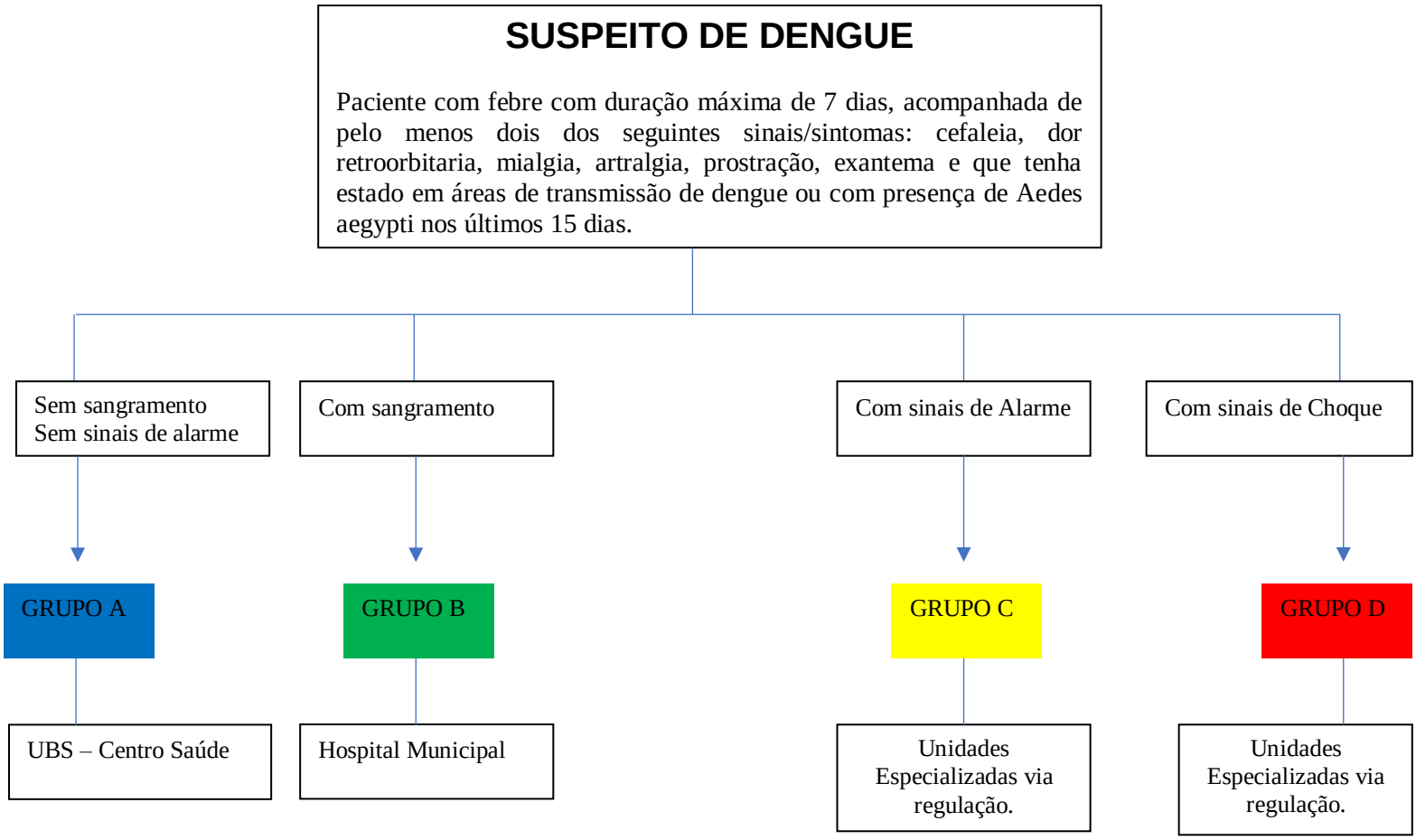
Obs: consultar manual do MS para conduta em condições clínicas especiais.

Prova do Laço

Verificar a PA (deitada ou sentada); Calcular o valor médio: (PA sistólica+ PA diastólica)/2;
Insuflar novamente o manguito até o valor médio e manter por cinco minutos em adulto (em crianças, 3 minutos) ou até o aparecimento de micro petéquias ou equimoses;
Desenhar um quadrado de 2,5 cm (ou uma área ao redor da falange distal do polegar) no antebraço.
Contar o número de micro petéquias no quadrado. A prova será positiva se houver 20 ou mais petéquias em adultos e 10 ou mais em crianças.

Todo caso suspeito de dengue deve ser notificado à vigilância

LOCAL DE ATENDIMENTO DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PARA A DENGUE



LOCAL DE ATENDIMENTO DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PARA A DENGUE

Grupo A – Unidades que atenderão ao Grupo A

- UBS Dr. Silvério Pinto de Oliveira

Grupo B – Unidades que atenderão ao Grupo B

- Hospital Municipal Maria Joaquina de Jesus

Grupo C – Unidades que atenderão ao Grupo C

- Hospitais Regionais
- HDT
- HUGOL/HGG/HUGO

Grupo D – Unidades que atenderão ao Grupo D

- Hospitais Regionais
- HDT

SINAN

República Federativa do Brasil
Ministério da Saúde

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO

FICHA DE INVESTIGAÇÃO **DENGUE E FEBRE DE CHIKUNGUNYA**

Nº

Caso suspeito de dengue: pessoa que viva ou tenha viajado nos últimos 14 dias para área onde esteja ocorrendo transmissão de dengue ou tenha presença de *Ae.aegypti* que apresente febre, usualmente entre 2 e 7 dias, e apresente duas ou mais das seguintes manifestações: náuseas, vômitos, exantema, mialgias, cefaléia, dor retroorbital, petéquias ou prova do laço positiva e leucopenia.

Caso suspeito de Chikungunya: febre de início súbito e artralgia ou artrite intensa com início agudo, não explicado por outras condições, que resida ou tenha viajado para áreas endêmicas ou epidêmicas até 14 dias antes do início dos sintomas, ou que tenha vínculo epidemiológico com um caso importado confirmado.

Dados Gerais

1 Tipo de Notificação — 2 - Individual

2 Agravo/doença — 1- DENGUE 2- CHIKUNGUNYA — Código (CID10) A 90 A 92

3 Data da Notificação

4 UF

5 Município de Notificação — Código (IBGE)

6 Unidade de Saúde (ou outra fonte notificadora) — Código

7 Data dos Primeiros Sintomas

Notificação Individual

8 Nome do Paciente

9 Data de Nascimento

10 (ou) Idade — 1 - Hora 2 - Dia 3 - Mês 4 - Ano

11 Sexo — M - Masculino F - Feminino I - Ignorado

12 Gestante — 1-1ºTrimestre 2-2ºTrimestre 3-3ºTrimestre 4- Idade gestacional ignorada 5-Não 6- Não se aplica 9-Ignorado

13 Raça/Cor — 1-Branca 2-Preta 3-Amarela 4-Parda 5-Indígena 9- Ignorado

14 Escolaridade — 0-Analfabeto 1-1ª a 4ª série incompleta do EF (antigo primário ou 1º grau) 2-4ª série completa do EF (antigo primário ou 1º grau) 3-5ª à 8ª série incompleta do EF (antigo ginásio ou 1º grau) 4-Ensino fundamental completo (antigo ginásio ou 1º grau) 5-Ensino médio incompleto (antigo colegial ou 2º grau) 6-Ensino médio completo (antigo colegial ou 2º grau) 7-Educação superior incompleta 8-Educação superior completa 9-Ignorado 10- Não se aplica

15 Número do Cartão SUS

16 Nome da mãe

Dados de Residência

17 UF

18 **Município de Residência** — **Código (IBGE)**

19 Distrito

20 Bairro

21 Logradouro (rua, avenida,...) — Código

22 Número

23 Complemento (apto., casa, ...)

24 Geo campo 1

25 Geo campo 2

26 Ponto de Referência

27 CEP

28 (DDD) Telefone

29 Zona — 1 - Urbana 2 - Rural 3 - Periurbana 9 - Ignorado

30 País (se residente fora do Brasil)

Dados clínicos e laboratoriais

Inv.

31 Data da Investigação

32 Ocupação

Dados clínicos

33 **Sinais clínicos** — **1-Sim 2- Não**

Febre; Cefaleia; Vômito; Dor nas costas; Artrite; Petéquias; Prova do laço positiva
Mialgia; Exantema; Náuseas; Conjuntivite; Artralgia intensa; Leucopenia; Dor retroorbital

34 **Doenças pré-existentes** — **1-Sim 2- Não**

Diabetes; Hepatopatias; Hipertensão arterial; Doenças auto-imunes
Doencas hematológicas; Doenca renal crônica; Doença ácido-péptica

Dados laboratoriais

Sorologia (IgM) Chikungunya

35 Data da Coleta da 1ª Amostra (S1)

36 Data da Coleta da 2ª Amostra (S2)

Exame PRNT

37 Data da Coleta

38 Resultado — S1 S2 PRNT — 1 - Reagente 2 - Não Reagente 3 - Inconclusivo 4 - Não Realizado

Sorologia (IgM) Dengue

39 Data da Coleta

40 **Resultado** — 1- Positivo 2- Negativo 3- Inconclusivo 4 - Não realizado

Exame NS1

41 Data da Coleta

42 **Resultado** — 1- Positivo 2- Negativo 3- Inconclusivo 4 - Não realizado

43 **Isolamento** Data da Coleta

44 Resultado — 1 - Positivo 2 - Negativo 3 - Inconclusivo 4 - Não Realizado

45 **RT-PCR** Data da Coleta

46 **Resultado** — 1 - Positivo 2 - Negativo 3 - Inconclusivo 4 - Não Realizado

47 Sorotipo — 1- DENV 1 2- DENV 2 3- DENV 3 4 - DENV 4

48 **Histopatologia** — 1- Compatível 2-Incompatível 3- Inconclusivo 4 - Não realizado

49 **Imunohistoquímica** — 1- Positivo 2- Negativo 3- Inconclusivo 4 - Não realizado

Hospitalização

50 **Ocorreu Hospitalização?** 1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado ☐

51 **Data da Internação**

52 **UF**

53 **Município do Hospital** **Código (IBGE)**

54 **Nome do Hospital** **Código**

55 **(DDD) Telefone**

Conclusão

Local Provável de Infecção (no período de 15 dias)

56 **O caso é autóctone do município de residência?** 1-Sim 2-Não 3-Indeterminado ☐

57 **UF**

58 **País**

59 **Município** **Código (IBGE)**

60 **Distrito**

61 **Bairro**

62 **Classificação** ☐
5- Descartado 10- Dengue 11- Dengue com Sinais de Alarme 12- Dengue Grave 13- Chikungunya

63 **Critério de Confirmação/Descarte** ☐
1 - Laboratório 2 - Clínico-Epidemiológico 3-Em investigação

64 **Apresentação clínica** ☐
1- Aguda
2- Crônica

65 **Evolução do Caso** ☐
1-Cura 2- Óbito pelo agravo 3- Óbito por outras causas 4-Óbito em investigação 9-Ignorado

66 **Data do Óbito**

67 **Data do Encerramento**

Preencher os sinais clínicos para Dengue com Sinais de Alarme e Dengue Grave

Dados Clínicos - Dengue com Sinais de Alarme e Dengue Grave

68 **Dengue com sinais de alarme** **1-Sim 2- Não**

- ☐ Hipotensão postural e/ou lipotímia
- ☐ Queda abrupta de plaquetas
- ☐ Vômitos persistentes
- ☐ Dor abdominal intensa e contínua
- ☐ Letargia ou irritabilidade
- ☐ Sangramento de mucosa/outras hemorragias
- ☐ Aumento progressivo do hematócrito
- ☐ Hepatomegalia >= 2cm
- ☐ Acúmulo de líquidos

69 **Data de início dos sinais de alarme:**

70 **Dengue grave** **1-Sim 2- Não**

Extravasamento grave de plasma:

- ☐ Pulso débil ou indetectável
- ☐ PA convergente <= 20 mmHg
- ☐ Tempo de enchimento capilar
- ☐ Acúmulo de líquidos com insuficiência respiratória
- ☐ Taquicardia
- ☐ Extremidades frias
- ☐ Hipotensão arterial em fase tardia

Sangramento grave:

- ☐ Hematêmese
- ☐ Melena
- ☐ Metrorragia volumosa
- ☐ Sangramento do SNC

Comprometimento grave de órgãos:

- ☐ AST/ALT > 1.000
- ☐ Miocardite
- ☐ Alteração da consciência
- ☐ Outros órgãos, especificar

71 **Data de início dos sinais de gravidade:**

Informações complementares e observações

Observações Adicionais

Investigador

Município/Unidade de Saúde

Cód. da Unid. de Saúde

Nome

Função

Assinatura